



MARATHON™ XLPE Cemented Cup Hip Prosthesis

en-bg-hr-ro-sl

Directory

en		Page 3
bg		Страница 12
hr		Stranica 23
ro		Pagina 33
sl		Stran 43

MARATHON™ XLPE Cemented Cup Hip Prosthesis

IMPORTANT INFORMATION – Please Read Before Use

Some products may not be licensed in all jurisdictions.



STERILE

See product label for method

Instructions for use (IFU) website

For access to the e-IFU and any additional languages visit www.e-IFU.com

Implant card, patient information leaflet (PIL) and website

The implant card (and implant card label) is provided in the package with the implant. The information in the patient information leaflet (PIL) is based on the information in this IFU. The ePIL can be found on the website below.

For access to the ePIL visit www.ic.jnjmedicaldevices.com

DEVICE DESCRIPTION

This is an Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) acetabular component with metal x-ray marker wires. A Total Hip Prosthesis is composed of individually packaged metal femoral hip stem, modular metal or ceramic femoral head and 2 piece metal-backed Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE), ceramic or all UHMWPE acetabular components designed to replace the natural articular surface of the hip joint.

MATERIALS AND RESTRICTED SUBSTANCES

The information below lists the substances in the implant. Additional trace substances may be present due to the manufacturing process. Please contact the address below for additional information.

These devices are a construct made from Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (97-99% w/w) titanium alloy (1-2% w/w) and stainless steel alloy (less than 1% w/w) depending on the size.

Example of Acronym used on label(s):	Material Description:	Material nominally contains the following substances:
PE, UHMWPE, P1	Ultra-High Molecular Weight Polyethylene	Polyethylene (100%)
T1, Ti1	Titanium Alloy	Titanium (90%) Aluminium (6%) Vanadium (4%)
S2, SS2	Stainless Steel Alloy (316L)	Iron (62%) Chromium (18%) Nickel (14%) Molybdenum (3%) Manganese (2%)

HOW SUPPLIED

These device(s) are individually packaged and supplied STERILE. Remove from the package using accepted aseptic technique only after the correct size has been determined. Do not use these components if the sterile packaging appears damaged or unintentionally opened.

INTENDED USER

These devices are not to be used by unqualified personnel. It is essential that the surgeon and operating room staff are fully conversant with the appropriate surgical technique for the implant and associated instruments.

INTENDED USE (PATIENT TARGET GROUP)

Intended use

Total hip arthroplasty is intended to replace the damaged hip joint articulation in patients where there is evidence of sufficient sound bone to seat and support the components.

WARNING: Use only DePuy modular femoral heads and DePuy acetabular components with DePuy modular femoral stems. The outer diameter of the femoral head **MUST** be matched to the inner diameter of the acetabular component.

Cemented components

This acetabular device labelled "For cemented use only" is intended for use with bone cement.

PATIENT POPULATION

The intended patient population are the skeletally mature where there is evidence of sufficient sound bone to seat and support the components.

INDICATIONS

Total hip replacement is indicated in the following conditions:

1. A severely painful and/or arthritic joint (typically due to non-inflammatory degenerative joint disease)
2. Failed previous hip surgery
3. Acute fracture of the femoral head or neck

CONTRAINDICATIONS

The following conditions are contraindications for total hip replacement:

1. Active local or systemic infection.
2. Loss of musculature, neuromuscular compromise or vascular deficiency in the affected limb rendering the procedure unjustified.
3. Poor bone quality, such as osteoporosis, where, in the surgeon's opinion, there could be considerable migration of the prosthesis or a significant change of the fracture of the femoral shaft and/or the lack of adequate bone to support the implant(s).
4. Charcot's or Paget's disease.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

CAUTION:

- Implants and trials components from different manufacturers or implant systems should never be used together.
- Hip prosthesis components should never be reimplanted. Even though the implant appears undamaged, the implant may have developed microscopic imperfections which could lead to failure.
- Always use a trial prosthesis for trial purposes. Trials should not be assembled with any components intended for permanent implantation. Trials must have the same configuration size, etc., as the corresponding components to be permanently implanted.
- Single use devices manufactured by DePuy have not been designed to undergo or withstand any form of alteration, such as disassembly, cleaning or re-sterilization, after a single patient use. Reuse can potentially compromise device performance and patient safety.
- Do not alter or modify implants in any way unless as described in the surgical technique.
- Quality bone stock is critical to ensure fixation of the device. Consider bone grafting and other reinforcement techniques, especially when performing revision surgery, to seat and support the device.

CAUTION: The following conditions, singularly or concurrently, tend to impose severe loading on the affected extremity, thereby placing the patient at higher risk for failure of the hip replacement:

1. Obesity or excessive patient weight.
2. Manual labour.
3. Moderate to high demand sports participation.
4. High levels of patient activity.
5. Likelihood of falls.
6. Alcohol or drug misuse addiction.
7. Other disabilities, as applicable.

CAUTION: The following conditions singularly or concurrently, tend to adversely affect the fixation of hip replacement implants:

1. Marked osteoporosis or poor bone stock.
2. Metabolic disorders or systemic pharmacological treatments leading to progressive deterioration of solid bone support for the implant (e.g., diabetes mellitus, steroid therapies, immunosuppressive therapies, etc.).
3. History of general or local infections.
4. Severe deformities leading to impaired fixation or improper positioning of the implant.
5. Tumors of the supporting bone structures.
6. Allergic reactions to implant materials (e.g., bone cement, metal).
7. Tissue reactions to implant corrosion or implant wear debris.
8. Disabilities of other joints (i.e., knees and ankles).

NOTE: Diabetes, at present, has not been established as a contraindication. However, because of the increased risk for complications such as infection, slow wound healing, etc., the physician should carefully consider the advisability of hip replacement in the severely diabetic patient.

The surgical and postoperative management of the patient must be carried out with due consideration for all existing conditions. Mental attitudes or disorders resulting in a patient's failure to adhere to the surgeon's orders may delay postoperative recovery and/or increase the risk of adverse effects including implant or implant fixation failure.

Excessive physical activity or trauma to the replaced joint may contribute to premature failure of the hip replacement by causing a change in position, fracture, and/or wear of the implants.

EXPECTED CLINICAL BENEFITS

Total hip arthroplasty is expected to provide increased patient mobility and reduce pain by replacing the damaged hip joint articulation in skeletally mature patients where there is evidence of sufficient sound bone to seat and support the components.

SUMMARY OF SAFETY AND CLINICAL PERFORMANCE (SSCP)

Some countries or regions have hip replacement registries which monitor the performance of hip implants. This registry data was analysed and shows that for a person's first total hip operation generally 95% (95 out of 100) last more than 10 years. This means that at 10 years about 5% (5 out of 100) of patients may have had additional operations to remove part(s). For revision hip replacement generally 80% last more than 10 years. This device meets this general implant lifetime. The risk of revision for an individual patient will depend on patient specific factors such as their anatomy, medical condition and lifestyle (e.g. weight and activity level), the surgical procedure and process.

A device specific SSCP can be found at the following link:

<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Note: The Eudamed link will only be available after the Eudamed database goes live.

Reporting of Serious Incidents

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Serious incident means any incident that directly or indirectly led, might have led or might lead to any of the following:

- a) the death of a patient, user or other person,
- b) the temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's state of health,
- c) a serious public health threat.

INFORMATION FOR USE

Preoperative

THE SURGEON SHOULD DISCUSS ALL PHYSICAL AND MENTAL LIMITATIONS PARTICULAR TO THE PATIENT AND ALL ASPECTS OF THE SURGERY AND THE PROSTHESES WITH THE PATIENT BEFORE SURGERY. The discussion should include the limitations and possible consequences of joint replacement, the necessity to follow the surgeon's instructions postoperatively and the information provided in the patient leaflet.

The preoperative planning and surgical techniques for implantation of these hip replacement components evolved from the surgical experience gained during the development of many hip prostheses. Surgeons should not begin the clinical use of any hip prosthesis before they have thoroughly

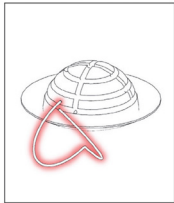
familiarized themselves with its specific implantation technique. Surgical technique brochures are available from DePuy.

Intraoperative

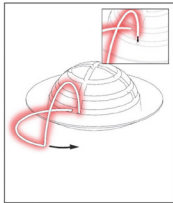
It is recommended that components at least one size larger and one size smaller than were preoperatively determined be available at surgery to accommodate intraoperative selection of the appropriate size(s).

Protective covers should be left on until the components are ready to be implanted. Do not use components if they have been dropped or have impacted a hard surface. Damage to the component may not be visible but could cause early failure of the prosthesis. The surgical instruments identified in the surgical technique have been designed for this arthroplasty procedure and must be used as shown in the surgical technique brochure.

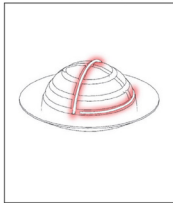
When performing revision surgery, it is imperative that any fibrous membrane encapsulating the failed prosthesis be removed in its entirety. Residual fibrous membranes may interfere with implant fixation. Review any pre-existing devices for damage to mating surfaces that would prevent adequate seating or locking of the new device. Improper selection, placement, or positioning of implants may result in unusual stress conditions and a subsequent reduction in the functional life of the implant. Increasing the anteversion of an acetabular component in total hip replacement may result in instability and/or dislocation. Prior to closure, the surgical site should be thoroughly cleansed of bone chips, extraneous bone cement, ectopic bone, etc. Foreign particles at the metal/plastic or ceramic/plastic interface may cause excessive wear. Range of motion should be thoroughly checked for improper mating, instability, or impingement and corrected as appropriate.



1.



2.



3.

X-Ray Marker Wire Assembly

Postoperative

Strict adherence by the patient to the surgeon's instructions and warnings is extremely important. Accepted practices should be followed in postoperative care.

The patient should be released from the hospital with complete written instructions and warnings regarding exercises and therapies and any limitations on their activities. Component malposition or the use of constrained hip or total hip with modular skirted head or tapered sleeve can decrease joint range of motion and can increase the potential for component wear, impingement premature dislocation or revision. In these cases, the surgeon should inform the patient that high range of motion activities should be avoided.

A continuing periodic patient follow-up is recommended because of the unknown functional lifetime of the implant in the specific patient, particularly with respect to the maintenance of implant fixation and bearing surfaces. Radiological investigations should be performed at each follow-up and compared with previous radiological investigations and correlated with the clinical assessment of the patient. If any radiological changes are observed, such as the occurrence of radiolucencies, bone resorption, or any changes in the position of an implant, these changes should be closely monitored to determine whether they are static or progressive and the patient treated appropriately.

ADVERSE EVENTS AND COMPLICATIONS

The following are generally the most frequently encountered adverse events and complications in hip arthroplasty:

General

The incidence and severity of complications in hip replacement are usually greater in revisions than in primary operations. Common problems encountered in revision surgery may include difficulty in placement of the incision, removal of ectopic bone and old bone cement, positioning and fixation of components, and/or obtaining adequate bony support. In general, increased operative time, blood loss, and risk of infection, pulmonary embolus and wound hematoma can be expected with revision procedures.

General

1. Change in position of the prosthetic components, often related to the factors listed in WARNINGS AND PRECAUTIONS.
2. Early or late loosening of the prosthetic components, often related to factors listed in WARNINGS AND PRECAUTIONS.

3. Fatigue fracture of the femoral stem or cup component, often related to factors listed in WARNINGS AND PRECAUTIONS.
4. Excessive wear or fracture of the bearing components due to: intraoperative damage to the prosthetic components, loose cement, bone fragments, metallic particles, ceramic particles or other factors listed in WARNINGS AND PRECAUTIONS.
5. Early or late infection.
6. Peripheral neuropathies. Subclinical nerve damage may also occur as a result of surgical trauma.
7. Tissue reactions, osteolysis, and/or implant loosening caused by metallic corrosion, allergic reactions, wear or particulate debris (such as loose cement, metallic, polyethylene or ceramic particles).
8. Residual pain in the hip.

Intraoperative

1. Femoral shaft or acetabular perforation, fissure, or fracture, which may require the use of internal fixation.
2. Trochanteric fracture.
3. Damage to blood vessels (e.g. iliac, obturator and femoral artery).
4. Temporary or permanent nerve damage (e.g. femoral, obturator or isolated peroneal nerve).
5. Subluxation or dislocation of the hip joint due to implant size or configuration selection, positioning of components and/or muscle and fibrous tissue laxity.
6. Lengthening or shortening of the affected extremity.
7. Surgical delay.

Early Postoperative

1. Cardiovascular disorders including venous thrombosis, pulmonary embolism and myocardial infarction.
2. Hematoma and/or delayed wound healing.
3. Subluxation or dislocation.
4. Disassociation of modular components.

Late Postoperative

1. Trochanteric avulsion from excessive muscular tension, weight-bearing, or inadvertent intraoperative weakening of the trochanter.
2. Aggravation of problems in the ipsilateral or contralateral knee and ankle joints due to leg length discrepancy, femoral medialization and/or muscular deficiencies.
3. Acetabular or femoral fracture due to trauma or excessive loading, particularly in the presence of poor bone stock caused by severe osteoporosis, bone defects from previous surgery, intraoperative reaming procedures, or bone resorption.

4. Bone resorption which may contribute to the deterioration of fixation and eventual loosening of the implant.
5. Decrease in joint mobility and range of motion (e.g. maybe caused by periarticular calcification or ossification).
6. Traumatic arthrosis of the ipsilateral knee secondary to intraoperative positioning, of the extremity during surgery.
7. Subluxation or dislocation.
8. Disassociation of modular components.

MRI SAFETY INFORMATION

 MRI Safety Information A patient with the DePuy MARATHON™ XLPE Cemented Cup Hip Prosthesis construct may be scanned under the following conditions. Failure to follow these conditions may result in injury to the patient.	
Name/Identification of device	MARATHON XLPE Cemented Cup Hip Prosthesis
Nominal value(s) of Static Magnetic Field [T]	1.5 T or 3.0 T
Maximum Spatial Field Gradient [T/m and gauss/cm]	30 T/m (3000 gauss/cm)*
RF Excitation	Circularly Polarized (CP)
RF Transmit Coil Type	Whole body transmit coil, Head RF transmit-receive coil
Operating Mode	Normal Operating Mode
Maximum Whole Body	2.0 W/kg (Normal Operating Mode)
Maximum Head SAR	Use of a head coil is not required for scanning of the hip
Limits on Scan Duration	2.0 W/kg whole body average SAR. Scan for up to 15 minutes followed by 15 minutes cooling period (may be repeated up to three times in a single imaging session)

MR Image Artifact	The presence of this implant is not expected to produce an image artifact extending further than 108 mm*
Additional instructions or information essential for safe use in the MR environment.	* Check all components of the hip construct for additional MR labelling information.

DISPOSAL

Safely dispose of all devices used in accordance with local procedures and guidelines.



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Тазобедрена протеза с циментирана капсула MARATHON™ XLPE

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ – Прочетете преди употреба

Някои продукти може да не са лицензирани във всички юрисдикции.



STERILE

Вижте етикета на продукта за метода

Уебсайт за инструкции за употреба (ИЗУ)

За достъп до еИЗУ и всички допълнителни езици посетете www.e-IFU.com

Карта на импланта, листовка с информация за пациента (ЛИП) и уебсайт

Картата на имплант (и етикетът на картата на импланта) се предоставя в опаковката с импланта. Информацията в листовката с информация за пациента (ЛИП) се основава на информацията в тези ИЗУ. еЛИП можете да намерите на уебсайта по-долу.

За достъп до еЛИП посетете www.ic.jnjmedicaldevices.com

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Това е ацетабуларен компонент от полиетилен със свръхвисоко молекулно тегло (UHMWPE) с метални маркерни рентгенови жички. Тоталната тазобедрена протеза се състои от индивидуално опаковани метално феморално бедрено стъбло, модулна метална или керамична

феморална глава и ацетабуларни компоненти от 2 части с метална основа от полиетилен със свръхвисоко молекулярно тегло (UHMWPE), керамика или изцяло от UHMWPE, предназначени да заменят естествената ставна повърхност на тазобедрена става.

МАТЕРИАЛИ И ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩЕСТВА

Информацията по-долу изброява веществата в импланта. Може да има допълнителни остатъчни вещества поради производствения процес. Свържете се с адреса по-долу за допълнителна информация.

Тези изделия са конструкция, изготвена от полиетилен със свръхвисоко молекулно тегло (97 – 99% w/w), титанова сплав (1 – 2% w/w) и сплав от неръждаема стомана (по-малко от 1% w/w) в зависимост от размера.

Пример за съкращение, използвано върху етикет(и):	Описание на материала:	Материалът номинално съдържа следните вещества:
PE, UHMWPE, P1	Полиетилен със свръхвисоко молекулно тегло	Полиетилен (100%)
T1, Ti1	Титанова сплав	Титан (90%) Алуминий (6%) Ванадий (4%)
S2, SS2	Сплав от неръждаема стомана (316L)	Желязо (62%) Хром (18%) Никел (14%) Молибден (3%) Манган (2%)

КАК СЕ ДОСТАВЯ

Това(тези) изделие(я) са опаковани индивидуално и се предоставят СТЕРИЛНИ. Извадете от опаковката, като използвате одобрена асептична техника, едва след като е определен правилният размер. Не използвайте тези компоненти, ако стерилната опаковка изглежда повредена или неволно отворена.

ПОТРЕБИТЕЛ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Тези изделия не трябва да се използват от неквалифициран персонал. Важно е хирургът и помощният персонал в операционната зала да са напълно запознати със съответната оперативна техника за импланта и свързаните инструменти.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА УПОТРЕБА (ПАЦИЕНТСКА ЦЕЛЕВА ГРУПА)

Предназначена употреба

Тоталната тазобедрена артропластика е предназначена да замества увредената тазобедрена става при пациенти, където има доказателства за достатъчно здрава костна тъкан, върху която да се разположат компонентите и която да ги поддържа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Използвайте само модулни феморални глави на DePuy и ацетабуларни компоненти на DePuy с модулните феморални стебла на DePuy. Външният диаметър на феморалната глава ТРЯБВА да съответства на вътрешния диаметър на ацетабуларния компонент.

Циментни компоненти

Това ацетабуларно изделие с надпис „Само за циментова употреба“ е предназначено за употреба с костен цимент.

ПАЦИЕНТСКА ПОПУЛАЦИЯ

Целевата пациентска популация е скелетно зрели пациенти, където има доказателства за достатъчно здрава костна тъкан, върху която да се разположат компонентите и която да ги поддържа.

ПОКАЗАНИЯ

Тоталната смяна на тазобедрена става е показана при следните условия:

1. Силно болезнена и/или артритна става (обикновено поради невъзпалително дегенеративно заболяване на ставите).
2. Неуспешна предишна операция на тазобедрената става.
3. Остра фрактура на феморалната глава или шийка.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Следните условия са противопоказания за тотална смяна на тазобедрена става:

1. Активна локална или системна инфекция.
2. Загуба на мускулатура, невромускулно нарушение или съдова недостатъчност в засегнатия крайник, което прави процедурата неоправдана.
3. Лошо качество на костта, като остеопороза, където, по мнение на хирурга, може да има значителна миграция на протезата или

значителна вероятност за фрактура на тялото на бедрената кост и/или липса на подходяща кост за опора на импланта(ите).

4. Болест на Шарко или болест на Пейджет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ВНИМАНИЕ:

- Импланти и пробни компоненти от различни производители или имплантни системи никога не трябва да се използват заедно.
- Компонентите на тазобедрената протеза никога не трябва да се реимплантират. Макар имплантът да изглежда неповреден, той може да е развил микроскопични несъвършенства, което може да доведе до неуспех.
- Винаги използвайте пробни протези за пробни цели. Пробните компоненти не трябва да бъдат комбинирани с никой компонент, предназначен за трайно имплантиране. Пробните компоненти трябва да имат същия конфигурационен размер и т.н. като съответните компоненти, които ще бъдат трайно имплантирани.
- Изделията за еднократна употреба, произведени от DePuy, не са предназначени да преминават или да издържат каквото и да е изменение като разглобяване, почистване или повторно стерилизиране след еднократна употреба при даден пациент. Възможно е повторната употреба да влоши функционирането на изделието и да застраши безопасността на пациента.
- Не изменяйте или модифицирайте импланти по никакъв начин, освен според описаното в хирургичната техника.
- Качествената костна плътност е от решаващо значение за осигуряване на фиксиране на изделието. Обмислете костен графт и други техники за подсилване, особено при извършване на операция за ревизия, за да разположите изделието и да му осигурите опора.

ВНИМАНИЕ: Следните състояния, самостоятелно или едновременно, е вероятно да наложат сериозно натоварване на засегнатия крайник, като по този начин излагат пациента на по-висок риск от неуспех на смяната на тазобедрена става:

1. Затлъстяване или прекомерно тегло на пациента.
2. Ръчен труд.
3. Участие в спорт с умерено до тежко натоварване.
4. Високо ниво на активност на пациента.
5. Вероятност от падане.
6. Пристрастеност към злоупотреба с наркотици или алкохол.
7. Друга инвалидност, ако има отношение.

ВНИМАНИЕ: Следните състояния, самостоятелно или едновременно, е вероятно да повлияят неблагоприятно на фиксирането на имплантите за смяна на тазобедрена става:

1. Изразена остеопороза или лоша костна плътност.
2. Метаболитни разстройства или системно медикаментозно лечение, водещо до прогресивно влошаване на твърдата костна опора за импланта (напр. захарен диабет, лечение със стероиди, лечение с имunosупресори и др.).
3. Анамнеза на общи или локални инфекции.
4. Сериозни деформации, водещи до влошена фиксация или неправилно позициониране на импланта.
5. Тумори на поддържащите костни структури.
6. Алергични реакции към материалите на импланта (напр. костен цимент, метал).
7. Тъканни реакции към корозия на импланта или частички от износване на импланта.
8. Заболявания на други стави (напр. колена и глезени).

ЗАБЕЛЕЖКА: Понастоящем диабетът не е установен като противопоказание. Въпреки това поради повишения риск от усложнения, като инфекция, бавно заздравяване на рани и т.н., лекарят трябва внимателно да прецени целесъобразността на смяна на тазобедрената става при тежко диабетно болен.

Хирургичното и следоперативно третиране на пациента трябва да се проведе с дължимото внимание за всички съществуващи заболявания. Психическата нагласа или разстройство, при които пациентът не спазва указанията на хирурга, може да забавят следоперативното възстановяване и/или да увеличат риска от нежелани реакции, включително счупване на импланта или неуспех на фиксацията.

Прекомерната физическа активност или травма на сменената става може да допринесе за преждевременен неуспех на смяната на ставата, като причини промяна на позицията, фрактура и/или износване на имплантите.

ОЧАКВАНИ КЛИНИЧНИ ПОЛЗИ

Тоталната артропластика на тазобедрената става осигурява по-добра подвижност на пациента и намалява болката чрез смяна на увредената тазобедрената става при скелетно зрели пациенти, където има доказателства за достатъчно здрава костна тъкан, върху която да се разположат компонентите и която да ги поддържа.

РЕЗЮМЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И КЛИНИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ (РБКД)

Някои държави или региони имат регистри за смяна на тазобедрената става, които следят функционирането на тазобедрените импланти. Тези данни от регистри са анализирани и сочат, че в 95% от случаите (95 от 100) първата тотална смяна на тазобедрена става при човек издържа повече от 10 години. Това означава, че след 10 години около 5% (5 от 100) от пациентите може да са имали допълнителни операции за отстраняване на част(и). За ревизионна смяна на тазобедрената става обикновено 80% издържат повече от 10 години. Това изделие отговаря на този генерален живот на импланта. Рискът от ревизия за отделен пациент ще зависи от специфични за пациента фактори, като неговата анатомия, здравословно състояние и начин на живот (напр. тегло и ниво на активност), хирургичните процедура и процес.

Специфични за изделието РБКД може да намерите на следната връзка: <http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Забележка: Връзката за Eudamed ще бъде достъпна само след като базата данни Eudamed стартира.

Докладване на сериозни инциденти

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да се докладва на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.

Сериозен инцидент означава всеки инцидент, който пряко или косвено е довел, може да е довел или може да доведе до някое от следните:

- а) смърт на пациент, потребител или друго лице,
- б) временно или постоянно сериозно влошаване на здравословното състояние на пациента, потребителя или друго лице,
- в) сериозна заплахата за общественото здраве.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предоперативен период

ПРЕДИ ОПЕРАЦИЯТА ХИРУРГЪТ ТРЯБВА ДА ОБСЪДИ ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПАЦИЕНТА, КАКТО И ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ОПЕРАЦИЯТА И ПРОТЕЗИТЕ С ПАЦИЕНТА. Дискусията трябва да включва ограниченията и възможните последици от смяната на ставата, необходимостта да се следват инструкциите на хирурга постоперативно и информацията, предоставена в листовката за пациента.

Предоперативното планиране и хирургичните техники за имплантиране на тези компоненти за смяна на тазобедрената става са произлезли

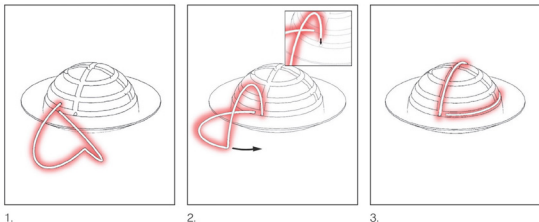
от хирургическия опит, натрупан по време на разработването на много тазобедрени протези. Хирурзите не трябва да пристъпват към клиничната употреба на която и да е тазобедрена протеза, преди напълно да са се запознали със специфичната техника за имплантация. Брошури за хирургична техника се предлагат от DePuy.

Интраоперативен период

Препоръчва по време на операция да има налични компоненти с поне един размер по-голям и един размер по-малък спрямо предоперативно определените такива, за да се осигури интраоперативният избор на подходящ(и) размер(и).

Защитните покрития трябва да се оставят, докато компонентите бъдат готови за имплантиране. Не използвайте компонентите, ако са били изпускани или са се ударили в твърда повърхност. Повредата на компонента може да не е видима, но да причини преждевременно счупване на протезата. Хирургичните инструменти, посочени в хирургичната техника, са предназначени за тази процедура по артропластика и трябва да се използват както е посочено в брошурата за хирургична техника.

Когато извършвате операция за ревизия, важно е всички фиброзни мембрани, капсулиращи неуспешната протеза, да бъдат премахнати изцяло. Остатъчните фиброзни мембрани могат да попречат на фиксацията на импланта. Прегледайте вече поставеното изделие за увреждане на контактните повърхности, което би попречило на правилното поставяне или заключване на новото изделие. Неправилният избор, поставяне или позициониране на имплантите може да доведе до необичайни условия на стрес и последващо съкращаване на функционалния живот на импланта. Увеличаването на антеверсията на ацетабуларния компонент при пълна подмяна на тазобедрената става може да доведе до нестабилност и/или дислокация. Преди затваряне оперативното поле трябва да бъде щателно почистено от костни частици, външен костен цимент, ектопична кост и др. Чуждите частици при интерфейса между метал/пластмаса или керамика/пластмаса могат да причинят прекомерно износване. Обхватът на движение трябва да бъде щателно проверен за неправилен контакт, нестабилност или пречка и да бъде коригиран в зависимост от ситуацията.



1. 2. 3.
Сглобяване на рентгеновата маркерна жичка

Следоперативен период

Изключително важно е пациентът да се придържа стриктно към инструкциите и предупрежденията на хирурга. При следоперативните грижи трябва да се следват одобрените практики.

Пациентът трябва да бъде изписан от болницата с пълни писмени инструкции и предупреждения относно физически упражнения, лечение и ограничения на дейностите. Неправилното разположение на компонентите или използването на ограничена или тотална смяна на тазобедрената става с модулна глава с периферия или скосен ръкав може да намали обхвата на движение на ставите и да увеличи потенциала за износване, удар, преждевременна дислокация или ревизия на компонентите. В тези случаи хирургът трябва да информира пациента, че е необходимо да се избягват дейности с широк обхват на движение.

Препоръчва се непрекъснато периодически проследяване на пациента поради неизвестния функционален живот на импланта при конкретния пациент, особено по отношение на поддържането на фиксацията на импланта и носещите повърхности. Рентгенологичните изследвания трябва да се извършват при всяко проследяване, да се сравняват с предишни рентгенологични изследвания и да се свързват с клиничната оценка на пациента. Ако бъдат забелязани някакви рентгенографски промени като поява на рентгенопрозрачност, костна резорбция или всякакви промени в позицията на даден имплант, тези промени трябва да се наблюдават отблизо, за да се определи дали те са статични или прогресивни, и пациентът да бъде третиран в зависимост от случая.

НЕЖЕЛАНИ СЪБИТИЯ И УСЛОЖНЕНИЯ

Следните нежелани събития и усложнения като цяло са най-често срещаните при тазобедрена артропластика:

Общи

Честотата и тежестта на усложненията при смяна на тазобедрена става обикновено са по-големи при ревизии, отколкото при първоначални операции. Чести проблеми, наблюдавани при операция за ревизия, може да включват затруднение при избора на място за инцизия, отстраняване на ектопична кост и стар костен цимент, позициониране и фиксация на компоненти и/или получаване на подходяща костна опора. Като цяло при ревизионните процедури може да се очаква увеличено време за операция, кръвозагуба и риск от инфекция, белодробна емболия и хематом на раната.

Общи

1. Промяна в позицията на протезните компоненти, често свързана с факторите, изброени в „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“.
2. Ранно или късно разхлабване на протезните компоненти, често свързано с факторите, изброени в „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“.
3. Счупване поради умора на феморалното стъбло или капсулния компонент, често свързано с факторите, изброени в „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“.
4. Прекомерно износване или счупване на носещите компоненти поради: интраоперативно увреждане на протезните компоненти, разхлабен цимент, костни фрагменти, метални частици, керамични частици или други фактори, изброени в „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“.
5. Ранна или късна инфекция.
6. Периферни невропатии. Може да се появи и субклинично увреждане на нерва като резултат от операционна травма.
7. Тъканна реакция, остеолиза и/или разхлабване на импланта, причинено от метална корозия, алергични реакции, износване или отпадни частици (като разхлабен цимент, метални, полиетиленови или керамични частици)
8. Остатъчна болка в тазобедрената става.

Интраоперативен период

1. Перфорация на феморалната или ацетабуларната кост, фисура или фрактура, които може да изискват използването на вътрешна фиксация.

2. Фрактура на трохантера.
3. Увреждане на кръвоносни съдове (напр. илиачна, obturatorна и femoralна артерия).
4. Временно или трайно увреждане на нерв (напр. femoralen, obturatorен или изолирано на peronealен нерв).
5. Сублуксация или дислокация на тазобедрената става поради избор на размер на импланта или на конфигурация, позициониране на компонентите и/или отпуснатост на мускулите и fibрозната тъкан.
6. Удължаване или скъсяване на засегнатия крайник.
7. Хирургично забавяне.

Ранен следоперативен период

1. Сърдечносъдови разстройства, включително венозна тромбоза, белодробна емболия и инфаркт на миокарда.
2. Хематом и/или забавено заздравяване на рани.
3. Сублуксация или дислокация.
4. Разкачане на модулни компоненти.

Късен следоперативен период

1. Трохантерна авулсия поради прекомерно мускулно разтягане, натоварване от тегло или непреднамерено интраоперативно разхлабване на трохантера.
2. Влошаване на проблеми в ипсилатералната или контралатералната коленна или глезенна става поради несъответствие в дължината на крака, бедрена медиализация и/или мускулна недостатъчност.
3. Ацетабуларна или femoralна фрактура поради травма или прекомерно натоварване, особено при наличието на лоша костна плътност, причинено от тежка остеопороза, костни дефекти от предишни операции, интраоперативни процедури за разширяване или костна резорбция.
4. Костна резорбция, която може да допринесе за влошаване на фиксацията и евентуално разхлабване на импланта.
5. Намаление на ставната мобилност и диапазона на движение (напр. може да причини periarticularна калцификация или осификация).
6. Травматична артроза на ипсилатералното коляно вторично на интраоперативно позициониране на крайника по време на операцията.
7. Сублуксация или дислокация.
8. Разкачане на модулни компоненти.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЯМР



Информация за безопасност при ЯМР

Пациент с конструкция на тазобедрена протеза с циментирана капсула DePuy MARATHON™ XLPE може да бъде сканиран при следните условия. Неспазването на тези условия може да доведе до нараняване на пациента.

Име/идентификация на изделието	Тазобедрена протеза с циментирана капсула MARATHON XLPE
Номинална(и) стойност(и) на статичното магнитно поле [T]	1,5 T или 3,0 T
Максимален градиент на пространствено поле [T/m и gauss/cm]	30 T/m (3000 gauss/cm)*
РЧ възбуждане	Циркулярно поляризиране (ЦП)
Тип РЧ трансмисивна намотка	Трансмисивна намотка тип цяло тяло, РЧ глава с намотка предаване-приемане
Режим на работа	Нормален режим на работа
Максимално за цяло тяло	2,0 W/kg (нормален режим на работа)
Максимална SAR за глава	Не се изисква употребата на глава с намотка за сканиране на тазобедрената става
Ограничения за продължителността на сканиране	2,0 W/kg средна за цялото тяло специфична абсорбционна стойност (SAR) Сканиране за до 15 минути, последвано от 15 минути период на охлаждане (може да се повтори до три пъти в една сесия за изобразяване)

Артефакт на изображенията от МР	Не се очаква присъствието на този имплант да доведе до образен артефакт на разстояние над 108 mm*
Допълнителни инструкции или информация от съществено значение за безопасна употреба в ЯМР среда.	* Проверете всички компоненти на тазобедрената конструкция за допълнителна информация за ЯМР етикетиране.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Всички изделия трябва да се изхвърлят безопасно съгласно местните процедури и препоръки.

UPUTE ZA UPORABU

Proteza za kuk s cementiranom čašicom MARATHON™ XLPE

VAŽNE INFORMACIJE – Pročitati prije uporabe

Neki proizvodi možda nisu licencirani u svim jurisdikcijama.



STERILE

Postupak potražite na naljepnici proizvoda

Internetska stranica za upute za uporabu

Elektroničkim uputama za uporabu (e-IFU) i dodatnim jezicima pristupite putem stranice www.e-IFU.com

Kartica implantata, upute s informacijama za pacijenta (PIL) i internetska stranica

Kartica implantata (i naljepnica kartice implantata) nalaze se u pakiranju s implantatom. Upute s informacijama za pacijenta (PIL) temelje se na informacijama navedenim u ovim uputama za uporabu. Elektroničke upute s informacijama za pacijenta (ePIL) nalaze se na internetskoj stranici u nastavku.

Elektroničkim uputama s informacijama za pacijenta (ePIL) pristupite putem stranice www.ic.injmedicaldevices.com

OPIS PROIZVODA

Ovo je acetabularna komponenta od polietilena iznimno visoke molekulske težine (UHMWPE) s rendgenskim markerima u obliku metalnih žica. Proteza za ukupnu zamjenu kuka sastoji se od pojedinačno pakirane metalne femoralne osnove za kuk, modularne metalne ili keramičke femoralne glave i 2 komada polietilena iznimno visoke molekulske težine (UHMWPE) s metalnom podlogom, keramičkih acetabularnih komponenata ili acetabularnih komponenata u potpunosti izrađenih od UHMWPE-a dizajniranih za zamjenu prirodne zglobne površine zgloba kuka.

MATERIJALI I OGRANIČENE TVARI

Podaci u nastavku navode tvari u implantatu. Zbog proizvodnog postupka postoji mogućnost postojanja drugih tvari u tragovima. Za dodatne informacije obratite se na adresu u nastavku.

Ovi su proizvodi tvorevine izrađene od polietilena iznimno visoke molekulske težine (97 – 99 % težinskog postotka), legure titanija (1 – 2 % težinskog postotka) i legure od nehrđajućeg čelika (manje od 1 % težinskog postotka), ovisno o veličini.

Primjer kratica korištenih na naljepnicama:	Opis materijala:	Materijal nazivno sadržava sljedeće tvari:
PE, UHMWPE, P1	Polietilen iznimno visoke molekulske težine	Polietilen (100 %)
T1, Ti1	Legura titanija	Titanij (90 %) Aluminij (6 %) Vanadij (4 %)
S2, SS2	Legura od nehrđajućeg čelika (316L)	Željezo (62 %) Krom (18 %) Nikal (14 %) Molibden (3 %) Mangan (2 %)

NAČIN ISPORUKE

Ovi su proizvodi pojedinačno pakirani i isporučuju se STERILNI. Izvadite ih iz pakiranja prihvaćenom aseptičnom tehnikom tek nakon što se utvrdi točna veličina. Ne upotrebljavajte ove komponente ako je sterilno pakiranje oštećeno ili nenamjerno otvoreno.

PREDVIĐENI KORISNIK

Ove proizvode ne smije upotrebljavati nekvalificirano osoblje. Ključno je da su kirurg i osoblje u operacijskoj dvorani u potpunosti upoznati s odgovarajućom kirurškom tehnikom za rad s implantatom i odgovarajućim instrumentima.

NAMJENA (CILJNA GRUPA PACIJENATA)

Namjena

Ukupna artroplastika kuka namijenjena je za nadomještanje oštećenog zglobnog područja kuka u pacijenata u kojih postoje dokazi da ima dovoljno čvrstih kosti za postavljanje i potporu za komponente.

UPOZORENJE: upotrebljavajte samo modularne glave bedrene kosti tvrtke DePuy i acetabularne komponente tvrtke DePuy s modularnim femoralnim osnovama tvrtke DePuy. Vanjski promjer glave bedrene kosti MORA biti usklađen s unutrašnjim promjerom acetabularne komponente.

Cementirane komponente

Ovaj acetabularni proizvod s oznakom „Samo za uporabu sa cementom” namijenjen je uporabi s koštanim cementom.

POPULACIJA PACIJENATA

Ciljna su populacija pacijenata koštano zrele osobe u kojih postoje dokazi da ima dovoljno čvrstih kosti za postavljanje i potporu za komponente.

INDIKACIJE

Ukupna zamjena kuka indicirana je u sljedećim uvjetima:

1. Jako bolan i/ili artritičan zglob (obično zbog neupalne degenerativne bolesti zglobova).
2. Prethodna operacija kuka koja nije uspjela.
3. Akutna fraktura glave ili vrata bedrene kosti.

KONTRAINDIKACIJE

Sljedeći su uvjeti kontraindikacije za potpunu zamjenu kuka:

1. Aktivna lokalna ili sustavna infekcija.
2. Gubitak mišićne mase, neuromuskularno oštećenje ili vaskularni nedostatak na zahvaćenom ekstremitetu zbog kojih je zahvat neopravdan.
3. Slaba kvaliteta kosti, npr. zbog osteoporoze, pri čemu po mišljenju kirurga može doći do znatnog pomaka proteze ili postoji ozbiljna mogućnost frakture tijela bedrene kosti i/ili nedostatka prikladne kosti za potporu implantata.
4. Charcotova ili Pagetova bolest.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

OPREZ:

- Implantati i probne komponente ili sustavi za implantaciju različitih proizvođača nikada se ne smiju koristiti zajedno.
- Komponente proteze za kuk ne smiju se ponovno implantirati. Iako se implantat doima neoštećenim, na njemu su možda nastala mikroskopska oštećenja ili iskrivljenja koja mogu uzrokovati neispravnosti.
- Uvijek upotrebljavajte probnu protezu u probne svrhe. Probne komponente ne smiju se sastaviti ni s jednim dijelom namijenjenim trajnoj implantaciji. Probne komponente moraju imati istu veličinu konfiguracije i sl. kao i odgovarajuće komponente koje se trajno implantiraju.
- Proizvodi za jednokratnu uporabu tvrtke DePuy nisu napravljeni da bi izdržali ili podnijeli bilo koji oblik izmjene, kao što su rastavljanje, čišćenje ili ponovna sterilizacija nakon uporabe na jednom pacijentu. Ponovna uporaba može narušiti radne značajke proizvoda i sigurnost pacijenta.
- Nemojte mijenjati niti modificirati implantate ni na koji način osim ako to nije opisano kirurškom tehnikom.
- Kvalitetna koštana masa presudna je za osiguravanje učvršćenja proizvoda. Razmislite o koštanim presatcima i drugim tehnikama ojačavanja, posebno kada izvodite revizijske kirurške zahvate, kako biste postavili i poduprli proizvod.

OPREZ: sljedeći uvjeti, pojedinačno ili istodobno, obično uključuju ozbiljno opterećenje za zahvaćeni ekstremitet, čime se pacijenta izlaže većem riziku od neuspjeha kirurškog zahvata zamjene kuka:

1. Pretilost ili prekomjerna težina pacijenta.
2. Ručni rad.
3. Sudjelovanje u sportovima umjerenog do visokog intenziteta.
4. Visoka razina aktivnosti pacijenta.
5. Vjerojatnost pada.
6. Ovisnost i zlouporaba alkohola ili droga.
7. Ostali invaliditeti, ako je primjenjivo.

OPREZ: sljedeći uvjeti pojedinačno ili istodobno obično negativno djeluju na učvršćenje implantata za zamjenu kuka:

1. Izražena osteoporoza ili loša koštana masa.
2. Metabolički poremećaji ili sustavno farmakološko liječenje koje dovodi do progresivnog pogoršanja čvrstoće koštane potpore za implantat (npr. dijabetes melitus, steroidne terapije, imunosupresivne terapije itd.).
3. Povijest općih ili lokalnih infekcija.
4. Teške deformacije koje dovode do oštećenja učvršćenosti ili nepravilnog postavljanja implantata.
5. Tumori potpornih koštanih struktura.

6. Alergijske reakcije na materijale implantata (npr. koštani cement, metal).
7. Reakcije tkiva na koroziju implantata ili ostatke uslijed trošenja implantata.
8. Invaliditeti na ostalim zglobovima (tj. koljena i gležnjevi).

NAPOMENA: trenutačno dijabetes nije utvrđen kao kontraindikacija. Međutim, zbog povećanog rizika od komplikacija kao što su infekcija, sporo zacjeljivanje rana itd., liječnik bi trebao pažljivo razmotriti uputnost zamjene kuka u pacijenata s teškim dijabetesom.

Kirurško i postoperativno liječenje pacijenta mora se provoditi s propisanim razmatranjem svih postojećih stanja. Mentalni stavovi ili poremećaji koji uzrokuju neuspjeh pacijenta da se pridržava naredbi kirurga mogu odgoditi postoperativni oporavak i/ili povećati rizik od štetnih učinaka, uključujući zatajenje implantata ili neuspješno učvršćenje implantata.

Pretjerana tjelesna aktivnost ili trauma zamijenjenog zgloba mogu pridonijeti preranom otkazivanju zamjenskog kuka uzrokujući promjenu položaja, prijelome, i/ili trošenje implantata.

OČEKIVANE KLINIČKE KORISTI

Očekuje se da će ukupna artroplastika kuka pacijentu pružiti povećanu pokretljivost i smanjiti bol zamjenom oštećenog zglobnog područja zgloba kuka u koštano zrelih pacijenata u kojih postoje dokazi da ima dovoljno čvrstih kosti za postavljanje i podupiranje komponenata.

SAŽETAK O SIGURNOSNOJ I KLINIČKOJ UČINKOVITOSTI (SSCP)

Neke države ili regije imaju registre za zamjenu kuka koji služe za nadzor rada implantata kuka. Podaci iz registra analizirani su i pokazuju da nakon prve ukupne operacije kuka u pacijenta obično 95 % (95 od 100) implantata traje više od 10 godina. To znači da je u 10 godina oko 5 % (5 od 100) pacijenata možda podvrgnuto dodatnim kirurškim zahvatima radi uklanjanja komponente ili komponenata. Kod revizijskog kirurškog zahvata zamjene kuka obično 80 % potraje dulje od 10 godina. Ovaj proizvod traje do kraja uporabnog vijeka implantata. Rizik revizije za pojedinog pacijenta ovisi o specifičnim čimbenicima pacijenta kao što su njegova anatomija, zdravstveno stanje i način života (npr. težina i razina aktivnosti), kirurški zahvat i postupak.

SSCP specifičan za proizvod možete pronaći na sljedećoj poveznici:
<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Napomena: poveznica za Eudamed bit će dostupna tek nakon pokretanja baze podataka Eudamed.

Prijavljivanje ozbiljnih štetnih događaja

Svaki ozbiljni štetni događaj koji se dogodi u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalaze.

Pojam ozbiljan štetni događaj znači svaki štetni događaj koji je izravno ili neizravno doveo, mogao dovesti ili može dovesti do jednog od sljedećega:

- a) smrt pacijenta, korisnika ili druge osobe
- b) privremeno ili trajno ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta, korisnika ili druge osobe
- c) ozbiljna prijetnja javnom zdravlju.

INFORMACIJE ZA UPORABU

Preoperativno

PRIJE KIRURŠKOG ZAHVATA KIRURG TREBA RAZGOVARATI S PACIJENTOM O SVIM FIZIČKIM I MENTALNIM OGRANIČENJIMA SPECIFIČNIMA ZA PACIJENTA I SVIM ASPEKTIMA KIRURŠKOG ZAHVATA I PROTEZE. Razgovor bi trebao obuhvaćati ograničenja i moguće posljedice zamjene zgloba, nužnost postoperativnog poštivanja uputa kirurga i informacije dane u uputama za pacijenta.

Preoperativno planiranje i kirurške tehnike za implantaciju ovih komponenata za zamjenu kuka razvile su se iz kirurškog iskustva stečenog tijekom razvoja mnogih proteza kuka. Kirurzi ne bi smjeli započeti kliničku uporabu bilo koje proteze kuka prije nego što se dobro upoznaju s njezinom specifičnom tehnikom implantacije. Brošure o kirurškoj tehnici dostupne su kod tvrtke DePuy.

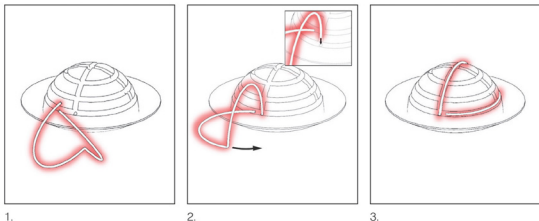
Tijekom zahvata

Preporučuje se da tijekom kirurškog zahvata budu dostupne komponente barem jedne veličine veće i jedne manje od onih koje su bile utvrđene prije zahvata, kako bi se uspješno postavilo implantat odgovarajuće veličine.

Zaštitne navlake trebaju prekrivati komponente sve dok komponente nisu spremne za implantaciju. Nemojte upotrebljavati dijelove ako su ispali ili udarili o tvrdi površinu. Oštećenje komponente možda neće biti vidljivo, ali može uzrokovati preuranjeni kvar proteze. Kirurški instrumenti naznačeni u kirurškoj tehnici napravljeni su za zahvat artroplastike i moraju se upotrebljavati kako je prikazano u brošuri o kirurškoj tehnici.

Kada se izvodi revizijski kirurški zahvat, neophodno je u cijelosti ukloniti bilo koju vlaknastu membranu koja inkapsulira neispravnu protezu. Preostale vlaknaste membrane mogu ometati učvršćenje implantata. Pregledajte ima li na spojnim površinama postojećih proizvoda oštećenja koja bi spriječila odgovarajuće postavljanje ili zaključavanje novog proizvoda.

Nepravilan odabir, postavljanje ili pozicioniranje implantata može dovesti do neuobičajenih uvjeta naprezanja i posljedičnog smanjenja funkcionalnog vijeka implantata. Povećanje anteverzije acetabularne komponente u ukupnoj zamjeni kuka može dovesti do nestabilnosti i/ili pomicanja. Prije zatvaranja mjesto kirurškog zahvata treba temeljito očistiti od krhotina kostiju, stranog koštanog cementa, ektopične kosti itd. Strane čestice na metalnom/plastičnom ili keramičnom/plastičnom spoju mogu uzrokovati pretjerano trošenje. Opseg kretanja treba temeljito provjeriti radi nepravilnog spajanja, nestabilnosti ili udara i ispraviti po potrebi.



Postavljanje rendgenskih markera u obliku žice

Postoperativno

Izuzetno je važno da se pacijent strogo pridržava uputa i upozorenja kirurga. Prihvaćene prakse treba slijediti u postoperativnoj njezi.

Pacijenta treba otpustiti iz bolnice s potpunim pisanim uputama i upozorenjima u vezi s vježbama i terapijama i svim ograničenjima u njegovim aktivnostima. Nepravilno postavljanje komponenti ili uporaba ograničene proteze za kuk ili ukupne proteze za kuk s modularnom obrubljenom glavom ili suženom navlakom može smanjiti raspon pokreta zglobova i može povećati vjerojatnost trošenja komponenti, udara, prijevremenog pomicanja ili revizijskog kirurškog zahvata. U tim slučajevima kirurg mora obavijestiti pacijenta da treba izbjegavati aktivnosti s velikim rasponom pokreta.

Preporučuje se kontinuirano periodično praćenje pacijenta zbog nepoznatog funkcionalnog vijeka implantata određenog pacijenta, posebno s obzirom na održavanje učvršćenja implantata i nosivih površina. Radiološka ispitivanja trebaju se provoditi pri svakom praćenju, uspoređivati s prethodnim

radiološkim istraživanjima i povezati s kliničkom procjenom pacijenta. Ako se primijete bilo kakve radiološke promjene, poput propusnosti za rendgensko zračenje, resorpcije kostiju ili bilo kakve promjena u položaju implantata, te promjene treba pažljivo nadzirati kako bi se utvrdilo jesu li statične ili progresivne te je li pacijent pravilno liječen.

ŠTETNI DOGAĐAJI I KOMPLIKACIJE

Sljedeće su najčešći neželjeni događaji i komplikacije pri artroplastiji kuka:

Općenito

Incidencija i težina komplikacija pri zamjeni kuka obično su veće u revizijama nego u prvotnim kirurškim zahvatima. Uobičajeni problemi pri revizijskom kirurškom zahvatu mogu uključivati poteškoće u pozicioniranju reza, uklanjanju ektopične kosti i starog koštanog cementa, postavljanju i učvršćivanju komponenata, i/ili održavanju odgovarajuće koštane potpore. Općenito, produženo trajanje zahvata, gubitak krvi i rizik od infekcije, plućna embolija i hematoma rane mogu se očekivati za vrijeme revizijskih postupaka.

Općenito

1. Promjena u položaju protetskih komponenata, često povezana s čimbenicima navedenima u odjeljku UPOZORENJA I MJERE OPREZA.
2. Rano ili kasno otpuštanje protetskih komponenata, često povezano s čimbenicima navedenima u odjeljku UPOZORENJA I MJERE OPREZA.
3. Fraktura femoralne osnove zbog zamora femoralne osnove ili čašice, često povezana s čimbenicima navedenima u odjeljku UPOZORENJA I MJERE OPREZA.
4. Pretjerano trošenje ili prijelom dijelova ležaja zbog: oštećenja protetskih komponenata tijekom zahvata, labavog cementa, fragmenata kostiju, metalnih čestica, keramičkih čestica ili drugih čimbenika navedenih u odjeljku UPOZORENJA I MJERE OPREZA.
5. Rana ili kasna infekcija.
6. Periferne neuropatije. Subkliničko oštećenje živaca može se pojaviti i kao posljedica kirurške traume.
7. Reakcije tkiva, osteoliza i/ili olabavljanje implantata uzrokovano korozijom metala, alergijske reakcije, trošenje ili ostaci čestica (poput olabavljenog cementa, metalnih, polietilenskih ili keramičkih čestica)
8. Preostala bol u kuku.

Tijekom zahvata

1. Perforacija, pucanje ili fraktura femoralne osnove ili acetabuluma, zbog čega može biti potrebno unutrašnje učvršćivanje.
2. Trohanterični prijelom.

3. Oštećenje krvnih žila (npr. ilijačne, stezne i femoralne arterije).
4. Privremeno ili trajno oštećenje živca (npr. femoralnog, opturatornog ili izoliranog peronealnog živca).
5. Subluksacija ili iščašenje zgloba kuka zbog veličine implantata ili odabira konfiguracije, pozicioniranja komponenata i/ili labavosti mišića i vezivnog tkiva.
6. Produljenje ili skraćivanje zahvaćenog ekstremiteta.
7. Odgoda kirurškog zahvata.

Nedugo nakon zahvata

1. Kardiovaskularni poremećaji, uključujući vensku trombozu, plućnu emboliju i infarkt miokarda.
2. Hematom i/ili odgođeno zacjeljivanje rana.
3. Subluksacija ili iščašenje.
4. Odvajanje modularnih komponenata.

Kasnije nakon kirurškog zahvata

1. Trohanterična avulzija zbog pretjerane mišićne napetosti, nošenja tereta ili nenamjernog intraoperativnog oslabljivanja trohantera.
2. Pogoršanje problema u ipsilateralnom ili kontralateralnom zglobo koljena i skočnim zglobovima zbog neslaganja dužine nogu, medijalizacije femura i/ili mišićnih nedostataka.
3. Fraktura acetabuluma ili femura uslijed traume ili pretjeranog opterećenja, posebno u prisutnosti loše koštane mase uzrokovane teškom osteoporozaom, oštećenjima kostiju u prethodnim kirurškim zahvatima, postupcima intraoperativnog razvrtnja ili resorpcije kosti.
4. Resorpcija kosti koja može pridonijeti slabljenju učvršćenja i olabavljanju implantata s vremenom.
5. Smanjenje pokretljivosti zglobova i raspona pokreta (npr. možda uzrokovano periartikularnom kalcifikacijom ili okoštavanjem).
6. Traumatska artroza ipsilateralnog koljena sekundarna zbog intraoperativnog položaja ekstremiteta tijekom zahvata.
7. Subluksacija ili iščašenje.
8. Odvajanje modularnih komponenata.

SIGURNOSNE INFORMACIJE O SNIMANJU MAGNETSKOM REZONANCIJOM (MRI)

Sigurnosne informacije o snimanju magnetskom rezonancijom (MRI)



Pacijent s DePuy MARATHON™ XLPE protezom za kuk s cementiranom čašicom može biti sniman pod sljedećim uvjetima. Nepridržavanje ovih uvjeta može rezultirati ozljedom pacijenta.

Naziv / ident. broj proizvoda	MARATHON XLPE proteza za kuk s cementiranom čašicom
Nazivne vrijednosti statičkog magnetskog polja [T]	1,5 T ili 3,0 T
Maksimalni prostorni gradijent polja [T/m i gauss/cm]	30 T/m (3000 gauss/cm)*
Ekscitacija RF energije	Cirkularno polarizirana (CP)
RF zavojnica za odašiljanje	Cijelo tijelo zavojnice za odašiljanje, glava RF zavojnice za odašiljanje i primanje signala
Način rada	Normalan način rada
Maksimalan za cijelo tijelo	2,0 W/kg (normalan način rada)
Maksimalan SAR za glavu	Korištenje zavojnice za glavu nije potrebno za snimanje kuka
Ograničenja trajanja snimanja	Prosječni SAR za cijelo tijelo od 2,0 W/kg. Skenirajte do 15 minuta nakon čega slijedi 15-minutno razdoblje hlađenja (može se ponoviti do tri puta u jednoj sesiji snimanja)
Artefakt slike tijekom MRI-ja	Ne očekuje se da prisutnost ovog implantata proizvede artefakt slike koji se proteže dalje od 108 mm*

Dodatne upute ili informacije neophodne za sigurnu uporabu u MR okruženju.

* Provjerite sve komponente konstrukcije kuka za dodatne informacije o MR označavanju.

ODLAGANJE U OTPAD

Sigurno u otpad odložite sve upotrijebljene proizvode u skladu s lokalnim postupcima i smjernicama.

ro

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Proteză de șold cu cupă cimentată MARATHON™ XLPE

INFORMAȚII IMPORTANTE – Citiți înainte de utilizare

Este posibil ca unele produse să nu fie autorizate în toate jurisdicțiile.



STERILE

Pentru metodă, consultați eticheta produsului

Site web cu instrucțiuni de utilizare (IFU)

Pentru a accesa instrucțiunile de utilizare în format electronic (eIDU) și alte limbi suplimentare, vizitați www.e-IFU.com

Cardul implantului, prospect informativ pentru pacienți (PIL) și site web

Cardul implantului (și eticheta cardului implantului) este furnizat în pachetul cu implantul. Informațiile din prospectul informativ pentru pacienți (PIL) se bazează pe informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare (IFU). Prospectul în format electronic (ePIL) poate fi găsit pe site-ul de mai jos.

Pentru a avea acces la prospectul în format electronic (ePIL), vizitați www.ic.injmedicaldevices.com

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Aceasta este o componentă acetabulară din polietilenă cu greutate moleculară ultra-înaltă (UHMWPE) cu fire metalice de marcare la raze X. O proteză totală de șold este compusă dintr-o tijă de șold femurală metalică ambalată individual, un cap femural modular metalic sau ceramic și componente acetabulare din polietilenă cu greutate moleculară ultra ridicată (UHMWPE) pe suport metalic, ceramică sau numai UHMWPE, cu 2 piese, concepute pentru a înlocui suprafața articulară naturală a articulației soldului.

MATERIALE ȘI SUBSTANȚE RESTRICȚIONATE

Informațiile de mai jos enumeră substanțele din implant. Pot fi prezente urme suplimentare de substanțe datorită procesului de fabricație. Vă rugăm să contactați adresa de mai jos pentru informații suplimentare.

Aceste dispozitive sunt o construcție realizată din polietilenă cu greutate moleculară ultra-înaltă (97-99 % g/g), aliaj de titan (1-2 % g/g) și aliaj de oțel inoxidabil (mai puțin de 1 % g/g), în funcție de dimensiune.

Exemplu de acronim utilizat pe etichetă (etichete):	Descrierea materialului:	Materialul conține, nominal, următoarele substanțe:
PE, UHMWPE, P1	Polietilenă cu greutate moleculară ultra-înaltă	Polietilenă (100 %)
T1, Ti1	Aliaj de titan	Titan (90 %) Aluminiu (6 %) Vanadiu (4 %)
S2, SS2	Aliaj de oțel inoxidabil (316L)	Fier (62 %) Crom (18 %) Nichel (14 %) Molibden (3 %) Mangan (2 %)

MOD DE PREZENTARE

Aceste dispozitive sunt ambalate individual și livrate STERILE. Îndepărtați componentele din ambalaj folosind o tehnică de asepsie acceptată, doar după ce ați stabilit dimensiunea corectă. Nu folosiți aceste componente dacă ambalajul steril pare deteriorat sau a fost deschis din greșeală.

UTILIZATORUL VIZAT

Aceste dispozitive nu trebuie utilizate de către personal necalificat. Este esențial ca chirurgul și personalul din sala de operație să fie pe deplin familiarizați cu tehnica chirurgicală corespunzătoare pentru implantul și instrumentele asociate.

UTILIZAREA PRECONIZATĂ (GRUPUL ȚINTĂ DE PACIENȚI)

Utilizarea preconizată

Artroplastia totală de șold este menită să înlocuiască articulația șoldului deteriorată la pacienții la care există dovezi ale unui os suficient de solid pentru așezarea și susținerea componentelor.

AVERTISMENT: utilizați numai capete femurale modulare DePuy și componente acetabulare DePuy împreună cu tije femurale modulare DePuy. Diametrul exterior al capului femural TREBUIE să se potrivească cu diametrul interior al componentei acetabulare.

Componente cimentate

Acest dispozitiv acetabular etichetat „Numai pentru uz cimentat” este destinat utilizării împreună cu ciment osos.

POPULAȚIA DE PACIENȚI

Populația de pacienți vizată este cea a pacienților maturi din punct de vedere scheletic, unde există dovezi ale unui os suficient de solid pentru așezarea și susținerea componentelor.

INDICAȚII

Artroplastia totală este indicată în următoarele condiții:

1. Durere articulară severă și/sau articulație artritică (de obicei atribuită unei boli degenerative articulare neinflamatorii).
2. Eșecul operației anterioare de șold.
3. Fractură acută a capului sau colului femural.

CONTRAINDICAȚII

Următoarele condiții reprezintă contraindicații pentru înlocuirea totală a șoldului:

1. Infecție activă locală sau sistemică.
2. Pierdere de masă musculară, compromiterea funcțiilor neuromusculare sau deficit vascular în membrul afectat, ceea ce face procedura nejustificată.
3. Masă osoasă de calitate scăzută, ca în cazul osteoporozei, unde, după părerea chirurgului, poate avea loc o migrare semnificativă a protezei sau există posibilitatea semnificativă a fracturării diafizei femurale și/sau a lipsei unei mase osoase corespunzătoare pentru implantul/urile respectiv(e).
4. Boala Charcot sau Paget.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

ATENȚIE:

- Implanturile și componentele de probă de la alți producători sau sistemele de implantare nu trebuie niciodată utilizate împreună.
- Componentele protezei de șold nu trebuie niciodată reimplantate. NOTĂ: chiar dacă implantul pare nedeteriorat, este posibil ca implantul să fi dezvoltat imperfecțiuni microscopice care ar putea duce la defectare.

- Folosiți întotdeauna o proteză de probă pentru testări. Protezele de probă nu trebuie asamblate cu componente destinate implantării permanente. Protezele de probă trebuie să aibă aceeași configurație, dimensiune etc. cu componentele corespunzătoare care urmează a fi implantate permanent.
- Dispozitivele de unică folosință fabricate de DePuy nu au fost proiectate pentru a fi supuse sau a suporta nicio formă de modificare, precum demontarea, curățarea sau resterilizarea, după utilizarea la un singur pacient. Reutilizarea poate compromite performanța dispozitivului și siguranța pacientului.
- Nu alterați sau modificați implanturile în niciun fel, cu excepția cazului în care acest lucru este descris în tehnica chirurgicală.
- Masa osoasă de calitate este esențială pentru a asigura fixarea dispozitivului. Luați în considerare grefarea oaselor și alte tehnici de consolidare, mai ales atunci când efectuați o intervenție chirurgicală de revizie, pentru a așeza și susține dispozitivul.

ATENȚIE: următoarele condiții, prezente individual sau simultan, tind să provoace solicitarea severă a extremității afectate, supunând astfel pacientul la risc ridicat de eșec al înlocuirii șoldului:

1. Obezitate sau greutate excesivă a pacientului.
2. Muncă manuală.
3. Participarea la sporturi de intensitate moderată până la înaltă.
4. Niveluri ridicate de activitate a pacientului.
5. Probabilitatea de căderi.
6. Dependența de alcool sau de droguri.
7. Alte dizabilități, după caz.

ATENȚIE: următoarele condiții, prezente individual sau simultan, tind să afecteze fixarea implanturilor de înlocuire a șoldului:

1. Osteoporoză marcată sau masă osoasă de calitate scăzută.
2. Afecțiuni metabolice sau tratamente farmacologice sistemice care duc la deteriorarea progresivă a suportului osos solid pentru implant (de exemplu, diabetul zaharat, terapiile cu steroizi, tratamentele imunosupresive etc.).
3. Antecedente de infecții generalizate sau locale.
4. Diformități severe care duc la fixarea defectuoasă sau poziționarea incorectă a implantului.
5. Tumori ale structurilor osoase de susținere.
6. Reacții alergice la materialele implantate (de exemplu, ciment osos, metal).
7. Reacții tisulare la corodarea implantului sau la reziduurile generate de uzura implantului.
8. Dizabilități la nivelul altor articulații (adică, genunchi și glezne).

NOTĂ: până în prezent, nu s-a stabilit că diabetul este o contraindicație. Cu toate acestea, din cauza riscului crescut de complicații precum infecțiile, vindecarea lentă a rănilor etc., medicul trebuie să fie precaut în recomandarea înlocuirii șoldului pentru pacienții care suferă de forme severe de diabet.

Monitorizarea chirurgicală și postoperatorie a pacientului trebuie efectuată luând în considerare toate condițiile existente. Atitudinile sau afecțiunile mentale care rezultă din nerespectarea de către pacient a recomandărilor chirurgului pot întârzia recuperarea postoperatorie și/sau crește riscul de reacții adverse, inclusiv eșecul (fixării) implantului.

Activitatea fizică intensă sau trauma fizică a articulației înlocuite poate contribui la eșecul prematur al înlocuirii șoldului, cauzând schimbarea poziției, fracturarea și/sau uzarea implanturilor.

BENEFICII CLINICE PREVĂZUTE

Se prevede că artroplastia totală a șoldului crește mobilitatea pacientului și reduce durerea prin înlocuirea articulației șoldului deteriorate la pacienții maturi din punct de vedere scheletic, unde există dovezi ale unui os suficient de solid pentru așezarea și susținerea componentelor.

REZUMATUL SIGURANȚEI ȘI PERFORMANȚEI CLINICE (SSCP)

Unele țări sau regiuni au registre de artroplastie care monitorizează performanța implanturilor de șold. Aceste date de registru au fost analizate și arată că, pentru prima operație totală de șold a unei persoane, în general 95 % (95 din 100) durează mai mult de 10 ani. Aceasta înseamnă că, la aproximativ 10 ani, circa 5 % (5 din 100) dintre pacienți ar fi putut avea operații suplimentare pentru îndepărtarea componentei(elor). În cazul artroplastiei de revizie a șoldului, 80 % durează în general mai mult de 10 ani. Acest dispozitiv respectă durata de viață generală a acestui implant. Riscul de revizie pentru un pacient individual va depinde de factori specifici pacientului, cum ar fi anatomia, starea medicală și stilul de viață (de exemplu, greutatea și nivelul de activitate), procedura și procesul chirurgical.

Un SSCP specific dispozitivului poate fi găsit accesând următorul link:
<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Notă: linkul Eudamed va fi disponibil numai după ce baza de date Eudamed va fi activată.

Raportarea incidentelor grave

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Incident grav este considerat acela care a dus, ar fi putut duce sau ar putea duce direct sau indirect la una dintre următoarele consecințe:

- a) decesul unui pacient, utilizator sau al unei alte persoane,
- b) deteriorarea gravă, temporară sau definitivă, a stării de sănătate a unui pacient, utilizator sau a unei alte persoane,
- c) un pericol grav la adresa sănătății publice.

INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA

Preoperatorii

CHIRURGUL TREBUIE SĂ DISCUTE CU PACIENTUL, ÎNAINTE DE INTERVENȚIA CHIRURGICALĂ, DESPRE TOATE LIMITĂRILE FIZICE ȘI MENTALE PENTRU PACIENT ȘI DESPRE TOATE ASPECTELE INTERVENȚIEI CHIRURGICALE ȘI ALE PROTEZEI. Discuția trebuie să includă limitările și posibilele consecințe ale înlocuirii șoldului, precum și necesitatea de a urma instrucțiunile postoperatorii ale chirurgului și informațiile din acest prospect.

Planificarea preoperatorie și tehnicile chirurgicale pentru implantarea acestor componente de înlocuire a șoldului au evoluat pe baza experienței chirurgicale dobândite în timpul dezvoltării multor proteze de șold. Chirurgii nu trebuie să înceapă utilizarea clinică a niciunei proteze de șold înainte de a se fi familiarizat bine cu tehnica de implantare specifică. DePuy pune la dispoziție broșuri cu tehnicile chirurgicale.

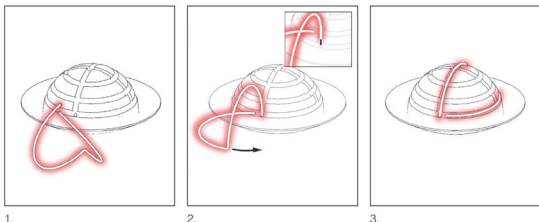
Intraoperatorii

Se recomandă disponibilitatea, pentru intervenția chirurgicală, a unor componente cu cel puțin o mărime mai mare sau o mărime mai mică decât cea stabilită preoperator, pentru asigurarea selecției intraoperatorii a dimensiunii(ilor) adecvate.

Capacele de protecție trebuie lăsate în poziție până când componentele sunt gata de implantare. Nu folosiți componente care au fost scăpate sau care au lovit o suprafață dură. Este posibil ca deteriorarea componentei să nu fie vizibilă, însă ar putea cauza eșecul prematur al protezei. Instrumentele chirurgicale identificate în tehnica chirurgicală au fost create pentru această procedură de artroplastie și trebuie să fie utilizate conform specificațiilor din broșura cu tehnica chirurgicală.

Când realizați intervenția chirurgicală de revizie, este obligatoriu ca orice membrană fibroasă care învelește proteza defectuoasă să fie îndepărtată

în totalitate. Membranele fibroase reziduale pot afecta fixarea implantului. Verificați orice dispozitiv preexistent pentru a depista eventualele deteriorări ale suprafețelor care intră în contact și care ar împiedica așezarea adecvată sau fixarea noului dispozitiv. Selectarea, plasarea sau poziționarea necorespunzătoare a implantului poate conduce la condiții neobișnuite de solicitare, având drept rezultat reducerea vieții funcționale a implantului. Creșterea anteversiei unei componente acetabulare în înlocuirea totală a șoldului poate rezulta în instabilitatea și/sau dislocarea articulației. Înainte de a închide, locul intervenției chirurgicale trebuie curățat complet de fragmente osoase, ciment osos străin, os ectopic etc. Particulele străine de pe interfața tip metal/plastic sau ceramică/plastic poate provoca uzura excesivă. Amplitudinea mișcărilor trebuie verificată riguros pentru a se depista conectarea neadecvată, instabilitatea sau lovirea și, după caz, trebuie corectată corespunzător.



Ansamblu fir de marcare la raze X

Postoperatorii

Respectarea strictă de către pacient a instrucțiunilor și atenționărilor chirurgului este extrem de importantă. În timpul îngrijirii postoperatorii trebuie urmate practicile acceptate.

Pacientul ar trebui să fie externat din spital cu instrucțiuni și avertismente scrise complete cu privire la exerciții și terapii și la orice limitare a activității sale. Poziționarea necorespunzătoare a componentelor sau utilizarea șoldului constrâns sau a șoldului total cu cap modular sau manșon conic poate reduce amplitudinea de mișcare a articulației și poate crește potențialul de uzură a componentelor, de luxație prematură, de lovire sau

de revizuire. În aceste cazuri, chirurgul trebuie să informeze pacientul că ar trebui evitată o gamă largă de activități de mișcare.

Se recomandă o monitorizare periodică continuă a pacientului din cauza duratei utile funcționale necunoscute a implantului la fiecare pacient în parte, în special în ceea ce privește menținerea fixării implantului și a suprafețelor portante. Investigațiile radiologice trebuie efectuate la fiecare control și comparate cu investigațiile radiologice anterioare și corelate cu evaluarea clinică a pacientului. Dacă se observă modificări radiologice, precum ocurența radiotransparențelor, resorbție osoasă sau orice modificări ale poziției unui implant, modificările respective trebuie monitorizate atent, pentru a se stabili dacă sunt statice sau progresive, iar pacientul trebuie tratat corespunzător.

EVENIMENTE ADVERSE ȘI COMPLICAȚII

Următoarele evenimente adverse și complicații sunt în general cele mai frecvente pentru artroplastia de șold:

Generale

Incidența și severitatea complicațiilor în artroplastia de șold sunt în general mai mari în timpul intervențiilor de revizie decât în timpul intervențiilor primare. Problemele frecvente întâlnite în timpul intervenției chirurgicale de revizie includ dificultatea plasării inciziei, îndepărtarea osului ectopic și cimentului osului vechi, poziționarea și fixarea componentelor și/sau obținerea unei susțineri osoase adecvate. În general, pentru procedurile de revizie se preconizează creșterea duratei de timp necesare intervenției, pierderi de sânge și risc de infecții, embolie pulmonară și hematomul plăgii.

Generale

1. Modificarea poziției componentelor protetice, adesea legată de factorii enumerați la AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII.
2. Slăbirea timpurie sau tardivă a componentelor protetice, adesea legată de factorii enumerați la AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII.
3. Fractură de efort a tijei femurale sau componentei cupei, adesea legată de factorii enumerați la AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII.
4. Uzura excesivă sau fracturarea componentelor portante cauzată de: deteriorarea intraoperatorie a componentelor protetice, ciment liber, fragmente osoase, particule metalice, particule ceramice sau alți factori enumerați la AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII.
5. Infecții timpurii sau tardive.
6. Neuropatii periferice. Leziuni nervoase subclinice, care pot fi asociate cu traumatisme chirurgicale.

7. Reacții tisulare, osteoliză și/sau mobilizarea implantului cauzate de corozivitatea metalică, reacții alergice, uzură sau particule reziduale (cum ar fi ciment liber, particule metalice, de polietilenă sau ceramice).
8. Durere reziduală în șold.

Intraoperatorii

1. Perforarea, fisurarea sau fracturarea acetabulară a axului femural, care ar putea necesita utilizarea unei metode de fixare internă.
2. Fractură trohanteriană.
3. Leziuni ale vaselor sangvine (de exemplu, artera iliacă, obturatorie și femurală).
4. Leziuni nervoase temporare sau permanente (de exemplu, nerv femural, obturator sau peronier izolat).
5. Subluxații sau dislocarea articulației șoldului din cauza mărimii sau configurației selectate, poziționării componentelor și/sau laxității țesuturilor musculare și fibroase.
6. Lungirea sau scurtarea extremității afectate.
7. Întârzieri chirurgicale.

Postoperatorii timpurii

1. Afecțiuni cardiovasculare care includ tromboză venoasă, embolie pulmonară și infarct miocardic.
2. Hematom și/sau întârzierea vindecării plăgilor.
3. Subluxație sau dislocare.
4. Disociere a componentelor modulare.

Postoperatorii târzii

1. Separare trohanteriană cauzată de tensiune musculară excesivă, susținerea de greutate sau slăbirea intraoperatorie accidentală a trohanterului.
2. Agravarea problemelor la genunchiul ipsilateral sau contralateral și la articulațiile gleznei din cauza discrepanței de lungime, medializării femurale și/sau a deficiențelor musculare.
3. Fractură acetabulară sau femurală cauzată de traume sau sarcini excesive, în special în prezența masei osoase de calitate scăzută, cauzată de osteoporoza severă, defecte osoase în urma unor intervenții chirurgicale anterioare, proceduri de alezare intraoperatorii sau resorbție osoasă.
4. Resorbție osoasă, care ar putea contribui la deteriorarea fixării și, în final, la slăbirea implantului.
5. Scăderea mobilității articulare și a amplitudinii de mișcare (de exemplu, poate fi cauzată de calcifierea sau osificarea periarticulară).

6. Artroză traumatică a genunchiului ipsilateral secundar poziției intraoperatorii a extremității în timpul intervenției chirurgicale.
7. Subluxație sau dislocare.
8. Disociere a componentelor modulare.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA RMN

 Informații privind siguranța RMN Un pacient cu o construcție cimentată de proteză DePuy MARATHON™ XLPE poate fi scanat în următoarele condiții. Nerespectarea acestor condiții poate duce la vătămarea pacientului.	
Denumirea/identificarea dispozitivului	Proteză de șold cu cupă cimentată MARATHON XLPE
Valoarea(orile) nominală(e) a(le) câmpului magnetic static [T]	1,5 T sau 3,0 T
Gradientul maxim al câmpului spațial [T/m și gauss/cm]	30 T/m (3000 gauss/cm)*
Excitație RF	Polarizat circular (CP)
Tipul bobinei de transmisie RF	Bobină de transmisie pentru întregul corp, bobină de transmisie-recepție RF cap
Modul de funcționare	Modul normal de funcționare
Valoare maximă pentru întregul corp	2,0 W/kg (modul normal de funcționare)
Valoare maximă SAR la nivelul capului	Pentru scanarea șoldului nu este necesară folosirea unei spire de cap
Limite privind durata scanării	2,0 W/kg SAR mediu pentru întregul corp. Scanarea timp de până la 15 minute, urmată de o perioadă de răcire de 15 minute (poate fi repetată de până la trei ori într-o singură sesiune de imagistică)

Artefact de imagine RM	Nu se preconizează că prezența acestui implant va produce un artefact de imagine care să se extindă la mai mult de 108 mm*
Instrucțiuni sau informații suplimentare esențiale pentru utilizarea în siguranță în mediul RM.	* Verificați toate componentele construcției soldului pentru informații suplimentare de etichetare RM.

ELIMINAREA

Eliminați în siguranță toate dispozitivele utilizate, în conformitate cu procedurile și liniile directoare locale.

sl NAVODILA ZA UPORABO

Kolčna proteza – cementna čašica MARATHON™ XLPE

POMEMBNE INFORMACIJE – pred uporabo preberite

Nekateri izdelki morda niso licencirani v vseh jurisdikcijah.



STERILE

Za metodo glejte oznako na izdelku

Spletno mesto z navodili za uporabo (IFU)

Za dostop do elektronske različice navodil za uporabo in morebitne dodatne jezikovne različice obiščite spletno mesto www.e-IFU.com

Kartica vsadka, dokument z informacijami za bolnika in spletno mesto

Kartica vsadka (in oznaka na kartici vsadka) je priložena v embalaži vsadka. Informacije v dokumentu z informacijami za bolnika temeljijo na informacijah v teh navodilih za uporabo. Elektronski dokument z informacijami za bolnika je na voljo na spodnjem spletnem mestu.

Za dostop do elektronskih navodil za uporabo obiščite www.ic.injmedicaldevices.com

OPIS PRIPOMOČKA

To je acetabularna komponenta iz polietilena z izjemno veliko molekulsko maso (UHMWPE) in kovinskimi rentgenskimi označevalnimi žicami. Totalno kolčno protezo sestavljajo posamezno pakirano kovinsko femoralno deblo, modularna kovinska ali keramična femoralna glava in dvodelne, s kovino ojačane acetabularne komponente iz polietilena z izjemno veliko

molekulska masa (UHMWPE), keramike ali v celoti iz UHMWPE, zasnovane za zamenjavo naravne sklepne površine kolka.

MATERIALI IN OMEJENE SNOVI

V spodnjih informacijah so navedene snovi, ki jih vsebuje vsadek. Zaradi proizvodnega procesa so lahko prisotne dodatne snovi v sledovih. Za dodatne informacije se obrnite na spodnji naslov.

Ti pripomočki so izdelek iz polietilena z izjemno veliko molekulska masa (97–99 % m/m), titanove zlitine (1–2 % m/m) in zlitine nerjavnega jekla (manj kot 1 % m/m), odvisno od velikosti.

Primer kratice, ki se uporablja na etiketah:	Opis materiala:	Material nominalno vsebuje naslednje snovi:
PE, UHMWPE, P1	polietilen z izjemno veliko molekulska masa	polietilen (100 %)
T1, Ti1	titanova zlitina	titan (90 %) aluminij (6 %) vanadij (4 %)
S2, SS2	zlitina nerjavnega jekla (316L)	železo (62 %) krom (18 %) nikelj (14 %) molibden (3 %) mangan (2 %)

NAČIN DOBAVE

Pripomočki so pakirani posamezno in dostavljeni STERILNI. Komponente vzemite iz ovojnine s sprejeto aseptično tehniko šele, ko določite pravilno velikost. Če je sterilna ovojna videti poškodovana ali ste jo nenamerno odprli, komponent ne uporabite.

PREDVIDENI UPORABNIK

Neusposobljeno osebje teh pripomočkov ne sme uporabljati. Izjemno pomembno je, da so kirurg in osebje v operacijski sobi v celoti seznanjeni z ustrežno kirurško tehniko, ki se uporablja za vsadek, in z njim povezanimi instrumenti.

PREDVIDENA UPORABA (CILJNA SKUPINA BOLNIKOV)

Predvidena uporaba

Namen totalne artroplastike kolka je zamenjati poškodovan kolčni sklep pri bolnikih, pri katerih obstajajo dokazi o zadostni zdravi kosti za namestitev in zagotavljanje podpore komponentam.

OPOZORILO: Uporabljajte samo modularne femoralne glave DePuy in acetabularne komponente DePuy z modularnimi femoralnimi debli DePuy. Zunanji premer femoralne glave MORA biti enak notranjemu premeru acetabularne komponente.

Cementirane komponente

Ta acetabularni pripomoček z oznako »Samo za uporabo s cementom« je namenjen uporabi s kostnim cementom.

POPULACIJA BOLNIKOV

Predvidena populacija bolnikov so skeletno zreli bolniki, pri katerih obstajajo dokazi o zadostni zdravi kosti za namestitev in zagotavljanje podpore komponentam.

INDIKACIJE

Zamenjava celotnega kolčnega sklepa je indicirana v naslednjih pogojih:

1. hudo boleč in/ali artritični sklep (običajno zaradi nevnetne degenerativne bolezni sklepov)
2. neuspela predhodna operacija kolka
3. akutni zlom femoralne glave ali vratu

KONTRAINDIKACIJE

Naslednja stanja predstavljajo kontraindikacije za popolno zamenjavo kolka:

1. aktivna lokalna ali sistemska okužba
2. izguba miškulature, nevromuskularne motnje ali vaskularno pomanjkanje v prizadeti okončini, zaradi česar je postopek neutemeljen
3. slaba kakovost kosti, kot je osteoporoza, ko bi po mnenju kirurga lahko prišlo do znatne migracije proteze oziroma obstoja precejšnje verjetnosti zloma femoralnega debla in/ali pomanjkanje ustrezne gostote kosti za podporo vsadku
4. Charcotova ali Pagetova bolezen

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

POZOR:

- Nikoli ne smete skupaj uporabiti vsadkov in poskusnih komponent različnih izdelovalcev ali različnih vsadnih sistemov.

- Komponent kolčne proteze nikoli ne smete ponovno implantirati. Tudi če je vsadek videti nepoškodovan, se lahko na njem pojavijo mikroskopsko majhne nepravilnosti, ki lahko povzročijo okvaro.
- Za preizkušanje vedno uporabite poskusno protezo. Poskusne proteze ne smejo vsebovati nobenih komponent, namenjenih trajni vsaditvi. Poskusne proteze morajo imeti enako konfiguracijo, velikost itd. kot ustrezne komponente, ki bodo trajno vsajene.
- Pripomočki za enkratno uporabo, ki jih izdelata družba DePuy, niso zasnovani za noben način spreminjanja, na primer razstavljanje, čiščenje ali ponovno steriliziranje po uporabi pri enem bolniku. Ponovna uporaba lahko ogrozi delovanje pripomočka in bolnikovo varnost.
- Vsadkov nikakor ne spreminjajte, razen če je spreminjanje opisano v kirurški tehniki.
- Za zagotavljanje fiksacije pripomočka je nujno potrebna kakovostna kostna masa. Razmislite o kostnih presadkih in drugih tehnikah ojačitve, še posebej pri revizijskem kirurškem posegu, za namestitvev in podporo pripomočku.

POZOR: Naslednja stanja lahko posamezno ali skupaj hudo obremenijo prizadeto okončino, zaradi česar se pri bolniku poveča tveganje neuspešne zamenjave kolka:

1. debelost ali prevelika telesna masa bolnika
2. fizično delo
3. sodelovanje pri zmernih do zelo napornih športnih aktivnostih
4. povečana bolnikova aktivnost
5. verjetnost padcev
6. zasvojenost z alkoholom ali mamili
7. druge nezmožnosti, če so prisotne

POZOR: Naslednja stanja lahko posamezno ali skupaj neželeno vplivajo na fiksacijo vsadkov pri zamenjavi kolka:

1. izrazita osteoporoza ali slaba kostna masa
2. presnovne motnje ali sistemska farmakološka zdravljenja, ki povzročajo progresivno propadanje kompaktne kostne mase, ki podpira vsadek (npr. diabetes mellitus, zdravljenje s steroidi, imunosupresivno zdravljenje itd.)
3. sistemske ali lokalne okužbe v anamnezi
4. hude deformacije, ki povzročajo slabo fiksacijo ali nepravilno namestitvev vsadka
5. tumorji na podpornih kostnih strukturah
6. alergijske reakcije na materiale vsadka (npr. kostni cement, kovino)
7. reakcije tkiv na korozijo vsadka ali na odpadke, nastale pri obrabi vsadka
8. okvare drugih sklepov (tj. kolena in gležnjev)

OPOMBA: Sladkorna bolezen do danes še ni bila ugotovljena kot kontraindikacija. Kljub temu mora zdravnik previdno pretehtati odločitev za zamenjavo kolka pri bolnikih s hudo sladkorno boleznijo zaradi povečanega tveganja za zaplete, kot so okužbe, počasno celjenje ran itd.

Pri kirurški in pooperativni obravnavi bolnika je treba ustrezno upoštevati vsa obstoječa stanja. Bolnikovo duševno stanje ali bolezni, ki vplivajo na njegovo neupoštevanje kirurgovih navodil, lahko upočasnijo pooperativno okrevanje in/ali povečajo tveganje za neželene učinke, vključno z odpovedjo vsadka ali odpovedjo fiksacije vsadka.

Pretirana fizična aktivnost ali poškodba zamenjanega sklepa lahko prispeva k predčasni odpovedi zamenjanega kolka, saj lahko povzroči spremembo položaja, zlom in/ali obrabo vsadkov.

PRIČAKOVANE KLINIČNE KORISTI

Totalna artroplastika kolka naj bi po pričakovanih izboljšala bolnikovo mobilnost in zmanjšala bolečine z zamenjavo poškodovanega kolčnega sklepa pri skeletno zrelih bolnikih, pri katerih je kost dovolj trdna za namestitvev in zagotavljanje podpore komponentam.

POVZETEK VARNOSTI IN KLINIČNE UČINKOVITOSTI (SSCP)

Nekatere države ali regije imajo registre za zamenjavo kolka, ki spremljajo delovanje kolčnih vsadkov. Analize podatkov iz registrov so pokazale, da so prve popolne zamenjave kolka pri ljudeh v 95 % (95 od 100) primerov večinoma zdržale več kot 10 let. To pomeni, da je po 10 letih okrog 5 % (5 od 100) bolnikov moralo prestati dodatne operacije za odstranitev dela/delov. Pri revizijski zamenjavi kolka jih običajno 80 % traja več kot 10 let. Ta pripomoček dosega splošno življenjsko dobo vsadka. Tveganje revizijskega posega pri posameznem bolniku je odvisno od dejavnikov, specifičnih za bolnika, kot so njegova anatomija, zdravstveno stanje in življenjski slog (npr. telesna masa in stopnja aktivnosti), kirurški poseg in proces.

SSCP za pripomoček je na voljo na naslednji povezavi:

<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Opomba: Povezava Eudamed bo na voljo šele po tem, ko bo zbirka podatkov Eudamed na voljo v živo.

Poročanje o resnih zapletih

O vsakem resnem zapletu, do katerega je prišlo v povezavi s pripomočkom, je treba poročati proizvajalcu in pristojnemu organu v državi članici, v kateri ima uporabnik sedež in/ali prebiva bolnik.

Resen zaplet pomeni kateri koli zaplet, ki je neposredno ali posredno privedel, je morda privedel ali bi lahko privedel do česar koli od naslednjega:

- a) smrti bolnika, uporabnika ali druge osebe
- b) začasnega ali trajnega resnega poslabšanja zdravja bolnika, uporabnika ali druge osebe
- c) resne grožnje javnemu zdravju

INFORMACIJE ZA UPORABO

Pred posegom

KIRURG SE MORA PRED OPERACIJO Z BOLNIKOM POGOVORITI O VSEH FIZIČNIH IN DUŠEVNIH OMEJITVAH, KI SO ZANJ POMEMBNE, TER O VSEH VIDIKIH OPERACIJE IN PROTEZE. Pogovor mora vključevati omejitve in morebitne posledice zamenjave sklepa, potrebo po upoštevanju kirurgovih navodil v pooperativnem obdobju in informacije iz navodil za bolnika.

Predoperativno načrtovanje in kirurške tehnike za vsaditev komponent za zamenjavo kolka izhajajo iz kirurških izkušenj, pridobljenih pri razvoju številnih kolčnih protez. Kirurgi ne smejo začeti uporabljati nobene kolčne proteze pri kliničnih posegih, dokler se temeljito ne seznani s specifično tehniko vsaditve. Brošure s kirurškimi tehnikami so na voljo pri družbi DePuy.

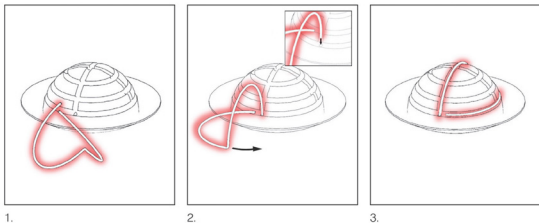
Med posegom

Priporočljivo je, da so med operacijo na voljo tudi za vsaj eno številko večje in manjše komponente od komponent, določenih v predoperativnem obdobju, za prilagoditev izbire ustreznih velikosti med posegom.

Zaščitni pokrovi morajo ostati na mestu, dokler komponente niso pripravljene za vsaditev. Ne uporabljajte komponent, če so padle na tla ali so udarile ob trdo površino. Poškodba komponente morda ne bo vidna, vendar lahko povzroči predčasno okvaro proteze. Kirurški instrumenti, navedeni v kirurški tehniki, so zasnovani za ta postopek artroplastike in jih je treba uporabljati, kot je prikazano v brošuri s kirurškimi tehnikami.

Pri izvajanju revizijske operacije je nujno, da v celoti odstranite vso vlaknasto membrano, ki obdaja okvarjeno protezo. Preostale vlaknaste membrane lahko ovirajo fiksacijo vsadka. Preglejte vse obstoječe pripomočke za poškodbe prilegajočih se površin, ki bi lahko preprečile ustrezno prileganje ali zaskočenje novega pripomočka. Neustrezna izbira, namestitvev ali pozicioniranje vsadkov lahko povzroči neobičajne stresne pogoje in posledično zmanjšanje funkcionalne življenjske dobe vsadka. Povečanje anteverzije acetabularne komponente pri vstavitvi totalne endoproteze kolka lahko povzroči nestabilnost in/ali dislokacijo. Pred zapiranjem

kirurške rane je treba z mesta posega temeljito odstraniti koščke kosti, odvečen kostni cement, ektopično kost ipd. Tujki na sklepnem stiku med kovino in plastiko ali keramiko in plastiko lahko povzročijo prekomerno obrabo. Temeljito je treba preveriti razpon gibanja, nepravilno prileganje, nestabilnost ali zatikanje in jih po potrebi popraviti.



Sklop rentgenskih označevalnih žic

Po operaciji

Izjemno pomembno je, da bolnik strogo upošteva kirurgova navodila in opozorila. Po operaciji je treba izvajati sprejete prakse.

Ob odpustu iz bolnišnice je treba bolniku v pisni obliki dati celovita navodila in opozorila za telesno vadbo, terapije in morebitne omejitve pri aktivnostih. Nepravilen položaj komponente ali uporaba omejene ali totalne kolčne proteze z modularno obrobjeno glavo ali zoženim tulcem lahko zmanjša razpon gibanja sklepa in poveča možnost obrabe komponente, zatikanja, prezgodnje dislokacije ali revizije posega. V teh primerih mora kirurg obvestiti bolnika, da se je treba izogibati visokemu obsegu gibalnih aktivnosti.

Zaradi neznanе funkcionalne življenjske dobe vsadka pri specifičnem bolniku se priporoča nadaljnje periodično spremljanje bolnika, zlasti kar zadeva vzdrževanje fiksacije vsadkov in nosilnih površin. Ob vsakem pregledu je treba opraviti radiološke preiskave, jih primerjati s predhodnimi radiološkimi preiskavami ter jih povezati s klinično oceno bolnika. V primeru zaznanih radioloških sprememb, kot je pojav radiotransparence, resorpcije kosti ali morebitnih sprememb v položaju vsadka, je treba spremembe temeljito spremljati in določiti, ali so statične ali progresivne, ter bolnika ustrezno zdraviti.

NEŽELENI DOGODKI IN ZAPLETI

V nadaljevanju so navedeni najpogostejši neželeni dogodki in zapleti pri artroplastiki kolka:

Splošno

Pogostnost in resnost zapletov pri zamenjavi kolka sta običajno večji pri revizijskih kot pri primarnih kirurških posegih. Pogoste težave, ki se pojavijo pri revizijski operaciji, lahko vključujejo težave pri določanju položaja reza, odstranjevanju ektopične kosti in starega kostnega cementsa, pozicioniranju in fiksaciji komponent in/ali pridobivanju ustrezne kostne podpore. Na splošno se lahko pri revizijskih kirurških posegih pričakujejo daljši čas posega, večja izguba krvi in povečano tveganje okužb, pljučne embolije ter hematoma v rani.

Splošno

1. spremembe položaja protetičnih komponent, ki so pogosto povezane z dejavniki, navedenimi v poglavju OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI
2. zgodnje ali pozno razrahljanje protetičnih komponent, ki je pogosto povezano z dejavniki, navedenimi v poglavju OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI
3. zlom femoralnega debla ali komponente čašice zaradi utrujenosti materiala, ki je pogosto povezan z dejavniki, navedenimi v poglavju OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI
4. prekomerna obraba ali zlom nosilnih komponent zaradi: poškodb protetičnih komponent med operacijo, prostih delcev cementsa, kostnih fragmentov, kovinskih delcev, keramičnih delcev ali drugih dejavnikov, navedenih v poglavju OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI
5. zgodnje ali kasnejše okužbe
6. periferne nevropatije; subklinične poškodbe živcev se lahko pojavijo tudi zaradi kirurške poškodbe
7. tkivne reakcije, osteoliza in/ali razrahljanje vsadka zaradi korozije kovine, alergijskih reakcij, obrabe ali drobcev (kot so prosti delci cementsa, kovinski, polietilenski ali keramični delci)
8. preostale bolečine v kolku

Med posegom

1. perforacija femoralnega debla ali acetabularna perforacija, razpoka ali zlom, ki lahko zahteva notranjo fiksacijo
2. trohanterni zlom
3. poškodbe krvnih žil (npr. iliakalne, obturatorne in femoralne arterije)
4. začasna ali trajna poškodba živca (npr. femoralni, obturatorni ali izolirani peronealni živec)

5. subluksacija ali dislokacija kolčnega sklepa zaradi velikosti vsadka ali izbire konfiguracije, pozicioniranja komponent in/ali ohlapnosti mišičnega in vlaknastega tkiva
6. podaljšanje ali skrajšanje prizadete okončine
7. odložitev kirurškega posega

Zgodnji pooperativni dogodki in zapleti

1. srčno-žilne bolezni, vključno z vensko trombozo, pljučno embolijo in miokardnim infarkt
2. hematoma in/ali upočasnjeno celjenje rane
3. subluksacija ali dislokacija
4. ločitev modularnih komponent

Pozni pooperativni dogodki in zapleti

1. trohanterna avulzija zaradi prevelike napetosti mišic, prenašanja teže ali nenamerne oslabitve trohantra med operacijo
2. poslabšanje težav v ipsilateralnem ali kontralateralnem kolenu in gležnju zaradi razlike v dolžini nog, medializacije stegenice in/ali mišične oslabitve
3. acetabularni ali femoralni zlom zaradi poškodbe ali prevelike obremenitve, zlasti v primeru slabe kostne mase, ki je posledica hude osteoporoze, okvar kosti, nastalih pri prejšnji operaciji, postopkov širitve med operacijo ali resorpcije kosti
4. resorpcija kosti, ki lahko prispeva k poslabšanju fiksacije in posledičnemu rahljanju vsadka
5. zmanjšana gibljivost sklepov in razpon gibljivosti (ki sta lahko posledica obsekalnega poapnjevanja ali osifikacije)
6. travmatska artroza ipsilateralnega kolena zaradi pozicioniranja okončine med posegom
7. subluksacija ali dislokacija
8. ločitev modularnih komponent

VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE MRI



Varnostne informacije glede MRI

Bolnika s kolčnim konstruktom, ki vsebuje cemetno čašico DePuy MARATHON™ XLPE, se lahko slika pod naslednjimi pogoji. Če teh pogojev ne upoštevate, lahko pride do poškodbe bolnika.

Ime/identifikacija pripomočka	Kolčna proteza s cementno čašico MARATHON XLPE
Nazivna vrednost/nazivne vrednosti statičnega magnetnega polja [T]	1,5 T ali 3,0 T
Največji prostorski gradient polja [T/m in gauss/cm]	30 T/m (3000 gauss/cm)*
RF vzbujanje	Krožno polarizirano (CP)
Tip RF oddajne tuljave	Oddajna tuljava za celotno telo, RF oddajno-sprejemna tuljava za glavo
Način delovanja	Običajni način delovanja
Največja vrednost za celo telo	2,0 W/kg (običajni način delovanja)
Največja SAR za glavo	Uporaba tuljave za glavo pri slikanju kolka ni potrebna.
Omejitve trajanja slikanja	2,0 W/kg povprečna SAR za celo telo. Slikanje do 15 minut, ki mu sledi 15 minut hlajenja (možnost do treh ponovitev v enem slikanju)
Artefakt na MR sliki	Po pričakovanjih naj prisotnost vsadka ne bi ustvarila artefakta na sliki, ki sega dlje kot 108 mm.*
Dodatna navodila ali informacije, ki so bistvene za varno uporabo v magnetnoresonančnem okolju	* Vse komponente kolčnega sestava preglejte za dodatne informacije o označevanju glede magnetnoresonančnega slikanja.

ODSTRANJEVANJE

Vse uporabljene pripomočke zavržite varno v skladu z lokalnimi postopki in smernicami.

INTERPRETATION OF SYMBOLS
ОБЪСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
TUMAČENJE SIMBOLA
INTERPRETAREA SIMBOLURILOR
RAZLAGA SIMBOLOV

D/DP

DEPUY
DEPUY
DEPUY
DEPUY
DEPUY



Batch code
Партиден код
Šifra serije
Număr lot
Koda serije



Consult Instructions for Use
Консултирайте се с инструкциите
за употреба
Pročitajte upute za uporabu
Consultați instrucțiunile de utilizare
Glejte navodila za uporabo



Catalogue Number
Каталоген номер
Kataloški broj
Număr de catalog
Kataloška številka



Caution
Внимание
Oprez
Atenție
Pozor



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 8888 2020
EU: +32 2 4037222

e-IFU website
Уебсайт с електронни инструкции
за употреба
Internetska stranica s elektroničkim
uputama za uporabu (e-IFU)
Site web cu instrucțiunile de utilizare în
format electronic
Spletno mesto z elektronskimi navodili
za uporabo



Manufacturer
Производитель
Proizvođač
Producător
Proizvajalec

STERILE

Sterile
Стерильно
Sterilno
Steril
Sterilno



Do not resterilize
Да не се стерилизира повторно
Nemojte ponovno sterilizirati
A nu se resteriliza
Ne sterilizirajte ponovno



Do not re-use
Да не се използва повторно
Nemojte ponovno upotrebljavati
A nu se reutiliza
Ni za ponovno uporabo



Use by Date
Годно до
Upotrijebiti do datuma
Data de expirare
Uporabiti do

Sterile GP

Sterilized using gas plasma
Стерилизирано с газова плазма
Sterilizirano plinskom plazmom
Sterilizat utilizând plasma gazoasă
Steriliziramo s plinsko plazmo



Do not use if package is damaged
Да не се използва, ако опаковката
е повредена
Ne upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno
A nu se utiliza dacă ambalajul
este deteriorat
Ne uporabite, če je ovojnina poškodovana
Ne uporabite, če je ovojnina poškodovana



MR Conditional
Условно при MP
Uvjetno sigurno za MR
Utilizare condiționată în mediul RM
Pogojno primerno za MR



Packaging unit

Опаковка

Jedinica pakiranja

Unitate de ambalare

Pakirna enota

MD

Medical Device

Медицинско изделие

Medicinski proizvod

Dispozitiv medical

Medicinski pripomoček



Recyclable

Подлежи на рециклиране

Može se reciklirati

Reciclabil

Primerno za recikliranje

UHMWPE, PE, P1

Ultra-high molecular weight
polyethylene

Полиетилен със свръхвисоко
молекулно тегло

Polietilen iznimno visoke molekulske
težine

Polietilenă cu greutate moleculară
ultra-înalță

Polietilen z izjemno veliko molekulsko
maso

MATERIAL

Material(s) of construction

Материал(и) на конструкцията

Materijal(i) izrade

Material(e) de construcție

Material(-i), uporabljen(-i) za izdelavo



Double sterile barrier system

Двойна стерилна бариерна система

Sustav dvostruke sterilne barijere

Sistem de bariere sterile duble

Sistem dvojne sterilne pregrade

MADE IN

Made in

Произведено в

Zemlja proizvodnje

Fabricat în

Izdelano v

T1 or Ti1

Titanium

Титан

Titanij

Titan

Titan

S2, SS2

Stainless steel

Неръждаема стомана

Nehrđajući čelik

Oţel inoxidabil

Nerjavno jeklo

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/ DEG/GRP/lb/OD/ID

Size/ size/ diameter/ inches/ feet/
degrees/ group/ pounds/ outer diameter/
inner diameter

Размер/размер/диаметър/инчове/футове/
градуси/група/фунтове/външен диаметър/
вътрешен диаметър

Veličina / veličina / promjer / inči / stope /
stupnjevi / grupa / funte / vanjski promjer /
unutarnji promjer

Dimensiune/mărimе/diametru/inchi/
picioare/grade/grup/livre/diametru exterior/
diametru interior

Velikost/velikost/premer/palci/čevlji/
stopinje/skupina/funti/zunanji premer/
notranji premer



DePuy Ireland UC
Loughbeg, Ringaskiddy
Co. Cork
Ireland
Tel: +353 214914000
Fax: +353 214914199



IFU-090260089-EMEA2
Rev. B